

26-1 목 통증

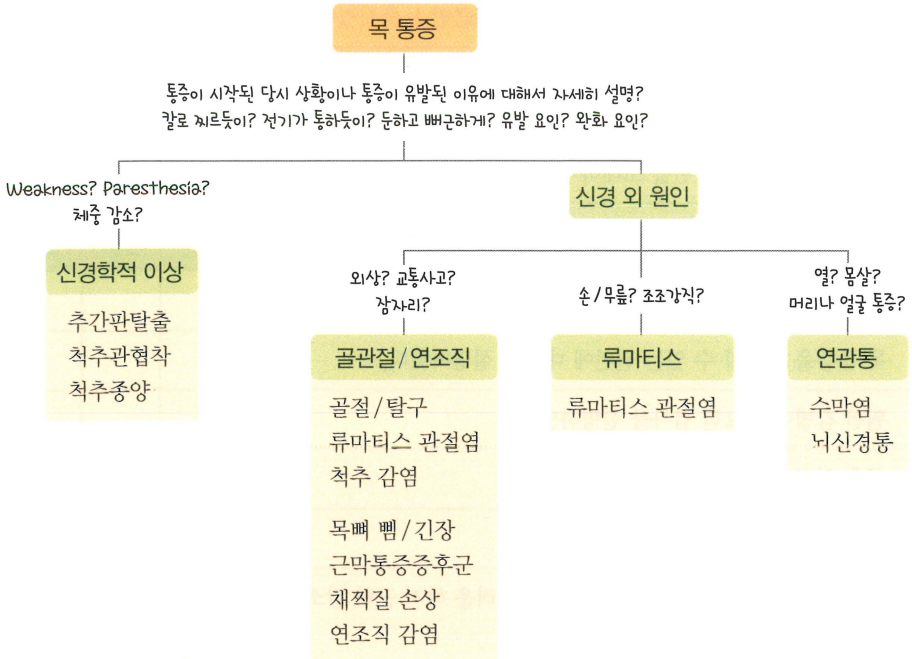
채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
목 통증의 위치를 물어보았다.				
목 통증이 발생한 시기(당시 상황) 및 빈도에 대해서 질문하였다.				
과거 치료 경험이 있을 때, 치료했을 때 반응은 어땠는지 물어보았다.				
통증의 양상(칼로 찌르듯, 전기가 통하듯, 둔하고 빠근한지) 및 강도에 대해서 질문하였다.				
방사통과 두통이 있는지 질문하였다.				
상하지에 감각 이상 및 근력이 감소되었는지 물어보았다.				
조조강직 지속 시간 및 열감, 발적, 붓기 등을 물어보았다.				
동반 증상을 확인하였다(손이나 무릎 관절 통증, 발열, 체중 감소, 발한, 털근두섬).				
목 통증이 악화되거나 완화되는 요인에 대하여 질문하였다.				
두통이 동반되거나 목이 뻣뻣해지지는 않았는지 확인하였다.				
최근 목소리가 변했거나 음식물을 삼킬 때 힘들지 않은지 확인하였다.				
팔, 다리, 어깨 등의 근력이 저하되지는 않았는지 확인하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
직업력 및 운동에 대해서 질문하였다.				
외상의 병력이나 수술력에 대해서 질문하였다.				
동반 질환에 대해서 질문하였다.				
골다공증검사 여부에 대해 질문하였다.				
복용하는 약물에 대해서 질문하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.				
목의 관절 상태를 시진하고, 촉진해 (압통점 여부 포함) 통증이 있는 부위를 정확히 확인하였다.				

통증이 있는 부위의 위치를 확인하였다.			
관절의 운동 범위를 확인하고 운동제한검사를 시행하였다.			
Spurling test를 정확히 시행하였다.			
Lhermitte sign을 확인하였다.			
환자의 전신 상태를 관찰하였다.			
상지의 감각, 운동 근력, 심부건 반사(DTR), 병적 반사(Hoffmann sign)를 확인하였다.			
수막 자극 징후를 시행하였다.			
위의 검사들을 대칭적으로 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
목 통증을 유발할 수 있는 원인에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			
생활 습관 교정에 대해서 설명하였다.			
내원이 필요한 상황(극심한 통증, 갑작스러운 하지 근력 감소 등)에 대해서 설명하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘



26-2 허리 통증

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
통증이 시작된 시기 에 대해서 질문하였다.			
등의 어느 부위 가 아픈지 물어보았다.			
통증이 시작될 때 발생한 상황 에 대해서 질문하였다.			
통증이 다리나 엉덩이 등 다른 부위에서도 나타나는지 질문하였다.			
통증의 양상 에 대해서 질문하였다.			
조조 강직, 지속 시간 및 열감, 발적, 붓기 등에 대해서 물어보았다.			
하루 중 증상 이 심할 때가 있는지 물어보았다.			
통증의 강도 를 확인하였다.			
과거 치료 경험이 있을 때, 치료했을 때 반응 은 어땠는지 물어보았다.			
동반 증상 을 확인하였다(발열, 체중 감소, 대소변 실금, 항문 주위 감각 저하, 다리 감각 이상, 다리 근력 저하).			
걸을 때 다리 통증 이 있는지와 쉴 때도 다리 통증이 있는지를 물어보았다.			
통증의 악화 인자 와 완화 인자 에 대해서 질문하였다(자세, 움직임 포함).			
병력 청취(기본)	예	아니오	
골절 이나 외상, 수술력 에 대해서 질문하였다.			
직업력 및 운동 여부 에 대해서 질문하였다.			
흡연 과거력 에 대해서 질문하였다.			
골다공증검사 여부 에 대해서 질문하였다.			
현재 복용하는 약물 에 대해서 질문하였다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자를 침대에 엎드리게 해 허리 통증 부위를 시진 하고 촉진 하며(압통 여부 포함), 정확한 통증 부위를 확인했으며, 척추의 정렬 상태 를 확인하였다.			
환자를 바로 눕힌 후 하지직거상검사 와 Patrick test 를 양측 하지 에서 실시해 좌우를 비교하였다.			

허리, 고관절, 슬관절, 족관절 운동 범위와 하지의 운동, 감각을 확인하였다.			
무릎과 발목의 심부건검사 를 시행하였다.			
하지 말초혈관 맥박을 확인하였다.			
자세와 걸음걸이를 확인하였다.			
Schober test를 시행하였다.			
하지 DTR 감소 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
허리 통증을 유발하는 원인에 대하여 설명하였다.			
감별에 필요한 검사를 설명하였다(X-ray, MRI, 골밀도검사 등).			
자세 교정의 필요성과 방법을 설명하였다.			
허리 통증을 줄일 수 있는 운동법과 생활 습관을 교육하였다.			
향후 치료에 대해서 설명하였다.			
향후 보조기 착용 등의 보존적 치료의 필요성, 수술적 치료가 필요할 수 있음을 설명하였다.			
내원이 필요한 상황(요실금, 변실금, 갑작스러운 하지 근력 및 감각 저하 등)에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

